

Trastornos del complejo articular

Tema 7 · Trastornos de la ATM

Panorama general

Los trastornos temporomandibulares se agrupan en tres grandes bloques:

- **Alteraciones del complejo cóndilo-disco:** desplazamientos y luxaciones del disco
- **Incompatibilidad estructural** entre superficies articulares: alteraciones morfológicas, adherencias, subluxación
- **Trastornos inflamatorios:** sinovitis, capsulitis, retrodiscitis, artritis

A esto se suman los trastornos musculares, que se ven en el Tema 8 y que en la práctica son los más frecuentes.

Desplazamiento discal con reducción

El disco está desplazado, casi siempre hacia **adelante y adentro**, cuando la boca está cerrada. Al abrir, el cóndilo lo recaptura y el disco vuelve a su posición: eso produce el **clic de apertura**. Al cerrar, el disco se vuelve a desplazar y suele haber un segundo clic, más suave, el **clic recíproco**.

Rasgos: apertura conservada, chasquido reproducible, dolor variable. La presencia de clic recíproco es lo que confirma la reducción.

Desplazamiento discal sin reducción

El disco está desplazado y el cóndilo **ya no logra recapturarlo** al abrir. El disco se convierte en un obstáculo mecánico.

Signos clave:

- Apertura **limitada**, típicamente por debajo de 30 mm
- **Desviación** de la línea media hacia el lado afectado al abrir
- **Desaparición del clic** que el paciente tenía antes
- Dolor al forzar la apertura

Que el clic desaparezca no es mejoría: suele ser progresión del cuadro. Es un dato que hay que preguntar dirigidamente.

Incompatibilidad estructural

Ocurre cuando las superficies articulares pierden su relación normal de deslizamiento.

- **Alteraciones morfológicas:** cambios de forma del cóndilo, la eminencia o el disco, por desarrollo, desgaste o remodelado. Producen ruidos reproducibles siempre en el mismo punto de la apertura.

- **Adherencias:** unión temporal entre superficies por falta de lubricación. Suelen ceder con el movimiento.
- **Adhesiones:** unión fibrosa **permanente**. No ceden solas y limitan de forma persistente.

Subluxación y luxación

- **Subluxación:** el cóndilo sobrepasa la eminencia articular en apertura amplia, pero el paciente **puede volver solo**. Se acompaña de un salto y a veces un ruido sordo. Es un cuadro de hipermovilidad.
- **Luxación:** el cóndilo queda **bloqueado** por delante de la eminencia y el paciente **no puede cerrar** sin ayuda. Requiere reducción manual.

La diferencia práctica es esa: si vuelve solo es subluxación, si necesita maniobra es luxación.

Sinovitis y capsulitis

- **Sinovitis:** inflamación de la membrana sinovial. Dolor articular localizado, que aumenta con la función.
- **Capsulitis:** inflamación de la cápsula articular. Dolor a la palpación del polo lateral del cóndilo y a los movimientos que la tensan.

Ambas comparten un dato útil: puede aparecer una **mordida abierta posterior del lado afectado**, porque el derrame separa las superficies y desplaza el cóndilo hacia abajo.

Retrodiscitis

Inflamación de los tejidos retrodiscales, la zona bilaminar por detrás del disco. Es un tejido muy vascularizado e innervado, así que duele bastante.

Causas: traumatismo directo en el mentón, desplazamiento posterior del cóndilo, o una relación retrusiva mantenida.

Signo típico: dolor que aumenta al apretar los dientes, y mordida abierta posterior del lado afectado por el edema.

Artritis y poliartritis

- **Osteoartritis:** proceso degenerativo por sobrecarga. Crepitación, dolor de larga evolución y cambios óseos en imagen.
- **Poliartritis:** la ATM se afecta dentro de una enfermedad **sistémica**, como artritis reumatoide, psoriásica o lupus. Casi siempre es bilateral y se acompaña de afectación de otras articulaciones.

Dato relevante: en la artritis reumatoide juvenil el daño condilar puede alterar el crecimiento mandibular y producir micrognatia. Ante sospecha de poliartritis, interconsulta con reumatología.

Tendinitis del temporal

Inflamación del tendón del músculo temporal en su inserción sobre la apófisis coronoides.

Se presenta como dolor en la región temporal que puede confundirse con cefalea o incluso con dolor dentario del maxilar. Aumenta con la palpación de la coronoides por vía intraoral y con la función.

Es un buen ejemplo de por qué el dolor orofacial exige diagnóstico diferencial: más de un paciente ha recibido tratamiento de conductos por un dolor que era muscular o tendinoso.

Exploración básica

- **Apertura máxima:** normal entre 40 y 55 mm interincisal. Menos de 40 mm es limitación.
- **Lateralidades y protrusiva:** se espera alrededor de 8 a 12 mm.
- **Trayectoria de apertura:** recta, desviada o en S. Una desviación que se corrige sugiere reducción discal; una que persiste sugiere restricción.
- **Palpación:** polo lateral del cóndilo y vía auricular.
- **Ruidos:** clic contra crepitación. El clic sugiere problema discal; la crepitación, cambio degenerativo.

Todo se registra con números, no con adjetivos.

Este material también está disponible en la plataforma, con ejercicios de autoevaluación por niveles y el asistente académico. dentipedia.dentilike.com.mx